



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PEDOMAN PENGORGANISASIAN UNIT REKAM MEDIS TAHUN 2025

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Pengorganisasian Unit Rekam Medis
Rumah Sakit Prima Husada
Tahun 2025

Disusun oleh:
Kepala Unit Rekam Medis



(Fina Fitriana Dwi Nur Hayati, A.Md.Kes)

Disetujui oleh:
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP)

Ditetapkan oleh:
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep)

TIM PENYUSUN

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

PENYUSUN

1. Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep
2. Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep
3. Fina Fitriana Dwi Nur Hayati, A.Md. Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pengorganisasian Unit Rekam Medis dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pengorganisasian Unit Rekam Medis ini, pelayananan unit rekam medis Rumah Sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Pasuruan, 1 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
TIM PENYUSUN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
PERATURAN DIREKTUR	1
BAB I	
PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG	4
1.2 DASAR HUKUM	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
BAB II	
GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	6
2.1 DESKRIPSI RS PRIMA HUSADA	6
2.2 SEJARAH INSTITUSI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	6
BAB III	
VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI, TUJUAN DAN MOTTO	7
3.1 VISI	7
3.2 MISI.....	7
3.3 FALSAFAH.....	7
3.4 LANDASAN 7 NILAI BUDI UTAMA	7
3.5 TUJUAN	7
3.6 MOTTO	7
BAB IV	
STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT	8
4.1 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI	8
4.2 KETERANGAN/PENGERTIAN	9
BAB V	
SUSUNAN ORGANISASI UNIT REKAM MEDIS	11
5.1 TANGGUNG JAWAB UNIT REKAM MEDIS	11
5.2 KEANGGOTAAN UNIT REKAM MEDIS	14
BAB VI	
URAIAN JABATAN	12
6.1 URAIAN JABATAN	12
6.2 TUGAS KLINIS	17
BAB VII	
TATA HUBUNGAN KERJA	22
7.1 SKEMA HUBUNGAN KERJA	22
7.2 HUBUNGAN INTERNAL	22
7.3 HUBUNGAN ESKTERNAL	22
BAB VIII	
POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI	23
8.1 POLA KETENAGAAN	23
BAB IX	
PROGRAM ORIENTASI	30
BAB X	
PERTEMUAN RAPAT	33
BAB XI	
PELAPORAN	34

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 946.3/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025**

TENTANG

**PEDOMAN PENGORGANISASIAN UNIT REKAM MEDIS
DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,**

- Menimbang : a. Bahwa Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo harus memenuhi kebutuhan Pengorganisasian Unit Rekam Medis hukum dimasykarakat sehingga perlu menetapkan Pengorganisasian Unit Rekam Medis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Rekam Medis;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 Tentang Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik;
8. Kepdirjen Nomor HK.01.07./MENKES/1596/.2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
9. Kepdirjen Nomor Hk.02.02/D/43961/2024 Tentang Pedoman survei Akreditasi Rumah Sakit;
10. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1041.21/DPM/I-KEP/DIR/VII/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur RS Prima Husada Sukorejo;
11. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 935.4/RSPHS/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PENGORGANISASIAN UNIT REKAM
MEDIS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat
- (2) Pedoman organisasi rumah sakit adalah suatu tata cara yang bertujuan untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mencapai visi, misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan tata kelola klinis yang baik
- (3) Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
- (4) Rekam Medis Elektronik (RME) adalah rekam medis yang dibuat, dikelola, dan disimpan dengan menggunakan sistem elektronik berbasis komputer atau digital di lingkungan rumah sakit, yang wajib terintegrasi secara nasional dengan platform data kesehatan milik kementerian kesehatan (SATUSEHAT) guna menjamin keamanan, kerahasiaan, dan kemudahan akses data pasien sesuai aturan hukum.

BAB II

PEDOMAN PENGORGANISASIAN UNIT REKAM MEDIS

Pasal 2

Rumah sakit menyelenggarakan pengelolaan rekam medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

Rumah Sakit menetapkan organisasi pengelolaan rekam medis dipimpin tenaga rekam medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan mengelolah rekam medis sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Pedoman Pengorganisasian Unit Rekam Medis digunakan sebagai acuan dalam organisasi Unit Rekam Medis di Rumah Sakit Prima Husada.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pedoman pengorganisasian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini
- (2) Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 946.3/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025
TENTANG
PEDOMAN PENGORGANISASIAN
UNIT REKAM MEDIS

PEDOMAN PENGORGANISASIAN UNIT REKAM MEDIS

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rekam medis berdasarkan sejarahnya selalu berkembang mengikuti kemajuan ilmu kesehatan dan kedokteran. Sejak masa pra kemerdekaan rumah sakit di Indonesia sudah melakukan pencatatan kegiatan medis, namun belum dilaksanakan dengan baik atau belum mengikuti penataan sistem informasi yang benar.

Tonggak yuridis dimulai dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran, di mana semua petugas kesehatan diwajibkan untuk menyimpan rahasia kedokteran termasuk dokumen medis pasien. Selanjutnya pada tahun 1972, melalui SK Menkes RI No. 034/BIRHUP/1972, pemerintah mempertegas kewajiban setiap rumah sakit untuk menyelenggarakan rekam medis.

Seiring dengan bergulirnya transformasi digital kesehatan di Indonesia, definisi dan media penyimpanan rekam medis kini telah berevolusi secara fundamental. Berdasarkan regulasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di Indonesia wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik (RME) yang terintegrasi dengan platform nasional SATUSEHAT milik Kementerian Kesehatan.

Rekam Medis Elektronik (RME) didefinisikan sebagai dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, yang dibuat dan dikelola dengan menggunakan sistem elektronik. Oleh karena itu, pengisian informasi klinis di dalam RME harus dilakukan secara lengkap, jelas, akurat, dan tepat waktu oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang berhak. Keberadaan RME yang valid sangat krusial karena berfungsi sebagai alat bukti hukum yang sah apabila terjadi kejadian tidak diharapkan (KTD) atau sengketa medis.

Mengingat pentingnya data kesehatan tersebut, unit penyelenggara rekam medis di setiap Fasyankes dituntut untuk menerapkan tata kelola berbasis sistem elektronik yang aman dan terstruktur. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 kini menjadi landasan hukum utama yang kuat dan mengikat bagi seluruh pelaku pelayanan kesehatan guna menjamin interoperabilitas data, aspek keamanan, serta perlindungan kerahasiaan data pasien di era digital

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Teknis Pejabat Perangkat Daerah Bidang Kesehatan

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pengelolaan Rekam Medis rumah sakit maka penanggung jawab pengelolaan rumah sakit harus melengkapi sistem dengan pedoman organisasi maupun pedoman pelayanan rekam medis harapannya penyelenggaraan rekam medis yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh tenaga kesehatan baik medis, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya dapat berjalan baik dan benar.

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

2.1. DESKRIPSI RS PRIMA HUSADA

Rumah Sakit Prima Husada berlokasi di Jalan Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan, Telepon (0343) – 6745000, Email ; info@rs-primahusada.com , www.rs-primahusada.com

Rumah Sakit Prima Husada adalah salah satu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan langsung khususnya pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur dan memiliki 2 Kepala Bidang dan 1 Kepala Bagian, yaitu Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Penunjang dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan, dalam tugasnya dibantu oleh para Kepala Instalasi dan Kepala Unit.

Rumah Sakit Prima Husada menyediakan beberapa pelayanan yang meliputi: pelayanan Instalasi Gawat Darurat 24 Jam, Instalasi Rawat Inap yang terdiri dari ruang isolasi, Kelas I,II,III dan VIP, Instalasi Kamar Operasi, *Intensive Care Unit*, Pelayanan Poli Spesialis yang terdiri dari pelayanan spesialis anak, spesialis bedah, spesialis bedah tulang, spesialis penyakit dalam, spesialis kandungan, spesialis syaraf, spesialis urologi, spesialis bedah plastik, spesialis paru, pelayanan gigi dan mulut. Selain itu juga membuka pelayanan laboratorium dan BDRS dan pelayanan radiologi.

Dalam upaya memberikan pelayanannya, rumah sakit dituntut memberikan pelayanan sebaik – baiknya sebagai *public service*. Meningkatnya tuntutan dapat dilihat dengan munculnya kritik – kritik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan yang diberikan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Rumah Sakit Prima Husada perlu menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan secara bertahap melalui upaya program peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

2.2 SEJARAH INSTITUSI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

Seiring dengan perkembangan penduduk dan peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lebih luas, maka kamipun berupaya mengembangkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, sehingga mengantarkan kami pada berdirinya Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Perjalanan Peningkatan Status Pelayanan:

Tahun 2018	: Pengajuan ijin Rumah Sakit Prima Husada
27 Desember 2018	: Ijin operasional keluar.
9 Januari 2019	: Rumah Sakit Prima Husada diresmikan oleh Bupati Kabupaten Pasuruan.
11 Januari 2019	: Rumah Sakit Prima Husada menerima pasien serta dilakukan bimbingan akreditasi.
23 April 2019	: Rumah Sakit Prima Husada sudah melaksanakan Akreditasi Versi SNARS Edisi 1.

BAB III

VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI, TUJUAN, DAN MOTTO

3.1 VISI

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo memiliki visi :

“Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat”

3.2 MISI

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo memiliki misi:

- a. Memberi pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat
- b. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien
- c. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

3.3. FALSAFAH

Memberikan pelayanan secara professional berlandaskan hati nurani yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.

3.4. LANDASAN 7 NILAI BUDI UTAMA

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama:

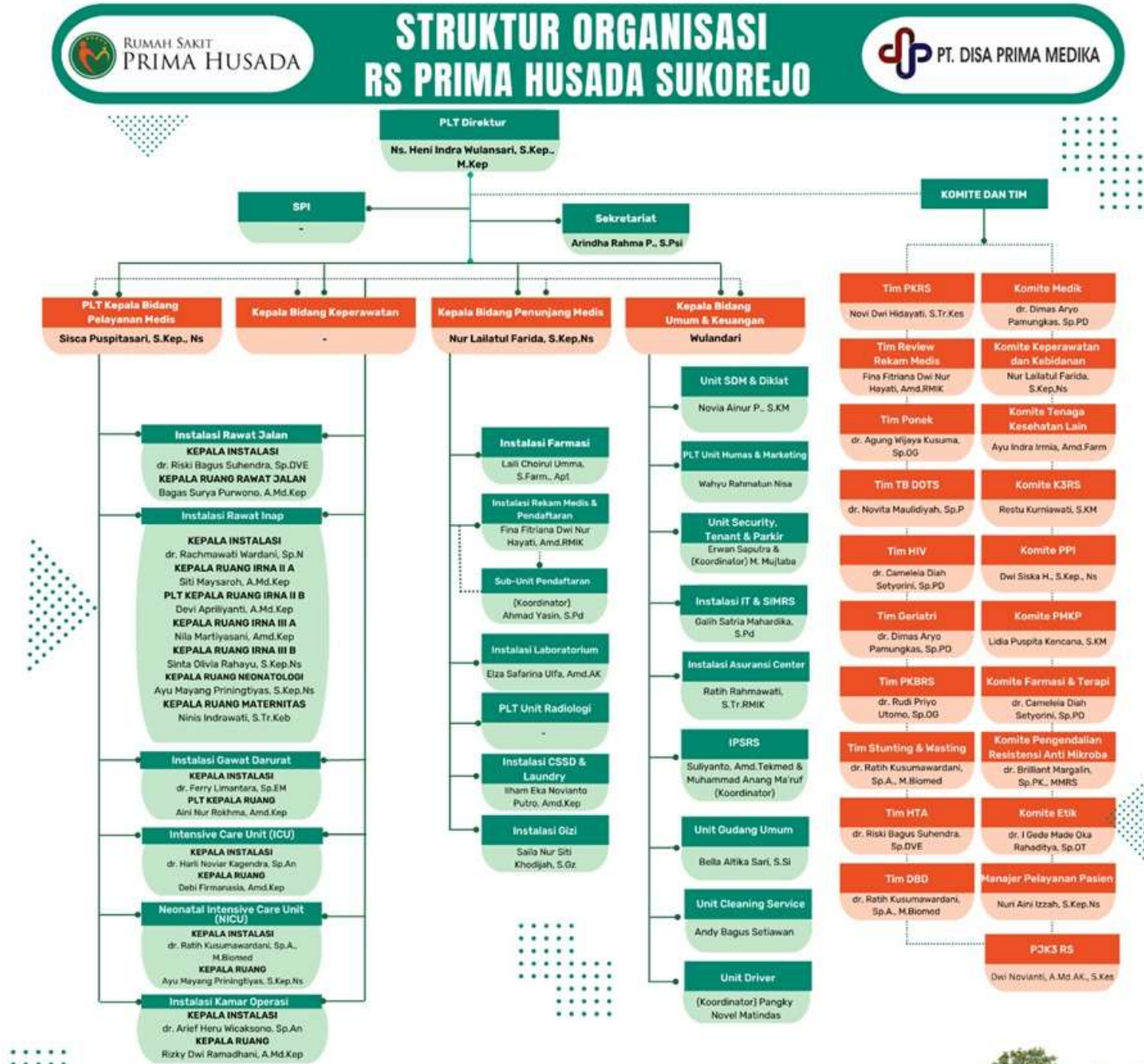
1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

3.5. TUJUAN

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo menjadi Rumah Sakit yang memberikan solusi kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya.

3.6. MOTTO

“Sahabat Menuju Sehat



4.2 KETERANGAN / PENGERTIAN

1. Unit Struktural

a. Direktur Rumah Sakit

Adalah kepala atau pejabat tertinggi di Rumah Sakit Prima Husada

b. Kepala Bidang / Kepala Bagian

Adalah pejabat yang membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang masing-masing yaitu :

- 1) Kepala Bidang Pelayanan Medik membantu Direktur dalam bidang Pelayanan Rumah Sakit.
- 2) Kepala Bidang Penunjang Medik membantu Direktur dalam bidang Penunjang Rumah Sakit.
- 3) Kepala Bagian Umum dan Keuangan membantu Direktur dalam bagian :
 - a) SDM yang meliputi ketenagakerjaan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia .
 - b) Keuangan dan Akutansi meliputi keuangan, akutansi dan pajak rumah sakit.
 - c) Umum meliputi : Saranan dan Prasarana Rumah Sakit, SIMRS, Rumah Tangga, Humas dan Pemasaran, Manajemen Kontrak, dan Pengaduan Pelayanan serta hubungan dengan pihak eksternal.
 - d) Sistem Manajemen Rumah Sakit

c. Kepala Instalasi dan Kepala Unit

Adalah suatu wadah struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dan memiliki fungsi tertentu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rumah sakit baik berfungsi pelayanan maupun pendukung operasional rumah sakit.

Berikut adalah daftar kepala instalasi dan kepala bagian :

- 1) Kepala Instalasi Rawat Jalan
- 2) Kepala Instalasi Rawat Inap
- 3) Kepala *Intensive Care Unit*
- 4) Kepala *Neonatal Intensive Care Unit*
- 5) Kepala Instalasi Gawat Darurat
- 6) Kepala Instalasi Kamar Operasi
- 7) Kepala Instalasi Hemodialisa
- 8) Kepala Instalasi Farmasi
- 9) Kepala Instalasi Rekam Medis
- 10) Kepala Unit Laboratorium
- 11) Kepala Unit Radiologi
- 12) Kepala Unit Gizi
- 13) Kepala Unit CSSD & Laundry
- 14) Kepala Unit Sterilisasi
- 15) Kepala Unit SDM & Diklat
- 16) Kepala Unit Humas & Marketing
- 17) Kepala Unit Security, Tenant & Parkir
- 18) Kepala Instalasi IT & SIM RS
- 19) Kepala Instalasi Asuransi Center
- 20) Kepala IPSRS
- 21) Kepala Unit Gudang Umum
- 22) Kepala Unit Cleaning Service
- 23) Kepala Unit Driver

2. Unit Non Struktural

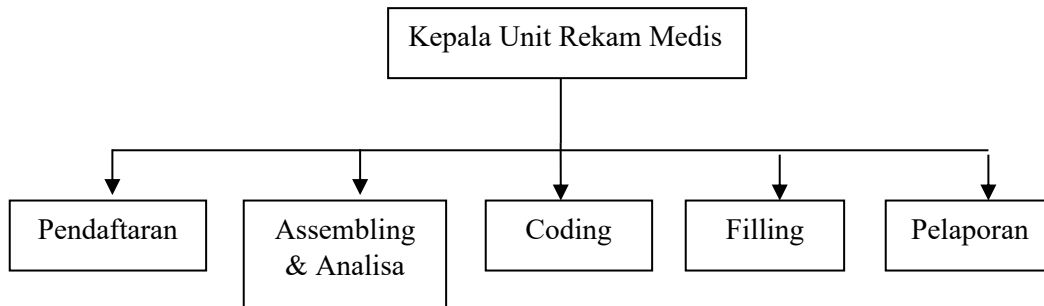
Adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli dan profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. Komite / Panitia / Tim yang ada di Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai berikut:

- Tim PKRS
- Komite Medik

- Tim Rekam Medis
- Komite Keperawatan dan Kebidanan
- Tim PONEK
- Komite Tenaga Kesehatan Lain
- Tim TB DOTS
- Komite K3RS
- Tim HIV
- Komite PPI
- Tim Geriatri
- Komite PMKP
- Tim PKBRS
- Komite Farmasi & Terapi
- Tim Stunting dan Wasting
- Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba
- Tim HTA
- Komite Etik
- Tim DBD
- Manajer Pelayanan Pasien
- PJK3 RS

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI UNIT REKAM MEDIS



5.1. TANGGUNG JAWAB UNIT REKAM MEDIS.

Dalam pengelolaan organisasinya, secara struktural Bagian Rekam Medis berada langsung dibawah Kepala Bidang Penunjang. Bagian Rekam Medis berfungsi sebagai salah satu “support division” yang memberikan kontribusi maksimal bagi semua “bussiness division”.

Secara fungsional, Bagian Rekam Medis melaporkan tanggung jawab pelayanannya kepada Ketua Unit/Instalasi yang ada, yakni :

1. Kepala Instalasi Gawat Darurat.
2. Kepala Instalasi Rawat Inap.
3. Kepala Instalasi Rawat Jalan
4. Kepala Instalasi Operasi .
5. Kepala Intensive Care Unit

5.2. KEANGGOTAAN UNIT REKAM MEDIS.

Bagian Rekam Medis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Rekam Medis yang bertanggung jawab secara struktural ke Kepala Bidang Penunjang dan bertanggung jawab secara fungsional kepada para Kepala Unit.

Unit Rekam Medis Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo secara garis besar
Terdiri dari :

1. Pendaftaran.
2. Filling / Penyimpanan Dokumen Rekam Medis.
3. Koding & Indeks Dokumen Rekam Medis Rawat Jalan, Rawat Darurat dan Rawat Inap.
4. Asembling / perakitan Dokumen Rekam Medis Rawat Jalan, Rawat Darurat dan Rawat Inap.
5. Pelaporan pelayanan internal dan eksternal.

BAB VI
URAIAN JABATAN

6.1. URAIAN JABATAN

No	Nama jabatan	Persyaratan jabatan
1	Kepala Unit Rekam Medis	1. Pendidikan : - Lulusan D3 Rekam Medis - Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku 2. Pengetahuan dan Keterampilan : - Pelatihan tentang manajemen rekam medis - Pelatihan Pelaporan RS - Menguasai pencatatan dan pelaporan dengan menggunakan program MS Excell 3. Pengalaman : Pengalaman kerja minimal 2 Tahun di bidang rekam medis
		4. Uraian Tugas : • Menyiapkan bahan rancangan kebijakan unit rekam medis dan informasi kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku • Membuat dan mengevaluasi sistem penerimaan pasien rawat jalan dan rawat inap. • Membuat dan mengevaluasi prosedur pencatatan rekam medis. • Merencanakan dan menetapkan formulir rekam medis. • Merencanakan dan mengevaluasi sistem dan prosedur penyimpanan dokumen rekam medis. • Merencanakan dan mengevaluasi sistem dan prosedur peminjaman dan pendistribusian dokumen rekam medis. • Merencanakan dan membuat kriteria dalam rangka retensi dokumen rekam medis. • Memeriksa kebenaran kode penyakit dan kode tindakan medis. • Membuat dan menyajikan laporan kegiatan medis rumah sakit untuk kepentingan manajemen maupun pihak lain yang berkepentingan. • Membuat laporan dan analisa data morbiditas, mortalitas dan tindakan operasi. • Melaksanakan penilaian terhadap rekam medis in aktif untuk menilai dokumen rekam medis bernilai guna atau tidak. • Merencanakan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit. • Membuat jadwal kerja, mengatur shift dinas, jadwal cuti dan libur. • Membuat permintaan kebutuhan sumber daya, atk, art, kebutuhan lain untuk pelaksanaan kegiatan unit rekam medis di Rumah Sakit Prima husada.

		• Membuat laporan intern dan ekstern rumah sakit secara berkala serta analisanya. • Membuat uraian pekerjaan bagi bawahan. • Mengawasi terhadap pelaksanaan kegiatan. • Memeriksa laporan kegiatan kunjungan rawat jalan, inap dan penunjang sebagai bahan pelaporan dan analisa. • Menyelesaikan masalah yang timbul di lingkungan unit rekam medis sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan. • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung atau yang terkait dengan kegiatan Unit rekam medis 5. Tanggung jawab : • Ketepatan dan kesesuaian rencana dan tata kerja di Unit rekam medis. • Ketepatan dan kebenaran pelaksanaan kegiatan: • Admission Dan Registrasi • Assembling dan indeks kode penyakit. • Statistik dan pelaporan rumah sakit. • Penyimpanan dan pendistribusian dokumen rekam medis yang sesuai dengan SPO, Juknis yang ditetapkan. • Ketepatan dan kesesuaian rencana kebutuhan sumber daya dengan realisasi. • Kebenaran dan ketepatan laporan kepada manajemen
		6. Wewenang • Menilai, menegur dan memotivasi bawahan di Unit rekam medis. • Mengatur rencana kegiatan penyelenggaraan Unit rekam medis. • Meminta arahan dari atasan. • Meminta masukan dari bawahan dan unit kerja lain yang terkait. • Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan
No	Nama jabatan	Persyaratan jabatan
2	Pendaftaran	1. Pendidikan : - Minimal lulusan SMA atau sederajat 2. Pengetahuan dan Keterampilan : - Menguasai atau bisa program komputer - Mampu berbahasa Inggris 3. Pengalaman : Pengalaman kerja minimal 2 Tahun di bidang rekam medis terutama pendaftaran
		4. Uraian tugas : • Menerima pendaftaran pasien rawat inap, rawat jalan • Melakukan identifikasi untuk memperoleh informasi kebutuhan pelayanan pasien rawat inap dan rawat jalan • Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir identitas sosial. • Entry data identitas sosial.

		• Meminta dokumen rekam medis pasien lama dari petugas penyimpanan.
		5. Tanggung Jawab : • Bertanggung jawab atas kebenaran data identitas sosial yang di <i>entry</i>. • Bertanggung jawab atas informasi yang diberikan. • Bertanggung jawab atas pelayanan pendaftaran pasien rawat inap. • Bertanggung jawab atas perangkat kerja
		6. Wewenang • Menghubungi dokter yang akan praktek untuk mengetahui kepastian kedatangannya. • Menghubungi pasien yang akan berobat untuk memastikan kedatangan pasien. • Memberikan masukan kepada atasan langsung
No	Nama jabatan	Persyaratan jabatan
3	Assembling dan Analisa	1. Pendidikan : - Lulusan D3 Rekam Medis - Memiliki STR dan SIK yang masih berlaku 2. Pengetahuan dan Keterampilan : - Pelatihan tentang manajemen rekam medis - Menguasai pencatatan dan pelaporan dengan menggunakan program MS Excell 3. Pengalaman : Pengalaman kerja minimal 2 Tahun di bidang rekam medis
		4. Uraian tugas : • Menerima dokumen rekam medis rawat inap dan rawat jalan dari penanggung jawab dokumen rekam medis. • Memeriksa kelengkapan isi dokumen rekam medis. • Menyusun dokumen rekam medis sesuai urutan yang telah ditentukan. • Melengkapi identitas pasien dan nomor rekam medis pada setiap lembar dokumen rekam medis. • Memisahkan dokumen rekam medis yang belum lengkap isinya dan diserahkan kepada penanggung jawab dokumen rekam medis untuk dikirim kepada yang berhak / berkewajiban melengkapi isi dokumen rekam medis tersebut. • Menyusun dan menyiapkan dokumen rekam medis baru rawat jalan maupun rawat inap untuk petugas pendaftaran. • Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk menyelesaikan, menangani bila terjadi penyimpangan / kasus yang terjadi dikegiatan assembling.
		5. Tanggung Jawab : • Bertanggung Jawab pada Kepala Instalasi RM • Kelengkapan dan kerapian isi dokumen RM
		6. Wewenang • Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan. • Mengusulkan perbaikan perangkat kerja.
No	Nama jabatan	Persyaratan jabatan
4	Coding	1. Pendidikan : - Lulusan D3 Rekam Medis

		- Memiliki STR dan SIK yang masih berlaku 2. Pengetahuan dan Keterampilan : - Pelatihan tentang manajemen rekam medis - Menguasai pencatatan dan pelaporan dengan menggunakan program MS Excell - Menguasai ICD 10 - Menguasai ICD 9 CM 3. Pengalaman : Pengalaman kerja minimal 2 Tahun di bidang rekam medis
		4. Uraian tugas : • Mengkode diagnosa setiap dokumen rekam medis pasien yang berobat. • Mengentry kode penyakit. • Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk menyelesaikan, menangani bila terjadi penyimpangan / kasus yang terjadi di kegiatan kode penyakit pasien rawat jalan dan rawat inap
		5. Tanggung Jawab : • Kebenaran indeks kode penyakit • Bertanggung Jawab pada Kepala Instalasi RM
		6. Wewenang • Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan • Mengusulkan perbaikan perangkat kerja
No	Nama jabatan	Persyaratan jabatan
5	Penyimpanan dan pendistribusian rekam medis (Filling)	1. Pendidikan : - Minimal lulusan SMA atau sederajat 2. Pengetahuan dan Keterampilan : Pelatihan tentang manajemen rekam medis 3. Pengalaman : Pengalaman kerja minimal 2 Tahun di bidang rekam medis
		4. Uraian Tugas : • Koordinasi permintaan dan pendistribusian dokumen rekam medis - Menerima permintaan dokumen rekam medis dari pendaftaran. - Mencatat dokumen rekam medis yang akan dikirim ke poliklinik atau ruang perawatan dalam SIM RS - Memberikan dokumen rekam medis pasien yang diambil dari ruang penyimpanan ke pendaftaran untuk disiapkan dokumennya oleh petugas pendaftaran sebelum diantar ke ruang pemeriksaan. - Melaksanakan serah terima dokumen rekam medis dengan petugas pendaftaran. • Memberikan dokumen rekam medis yang baru diterima ke petugas Assembling • Menerima dokumen rekam medis dari petugas Assembling dan Indeks Kode Penyakit untuk disortir menurut dua angka akhir, dan memasukkan dokumen ke dalam rak penyimpanan sesuai nomor. • Melayani permintaan peminjaman dokumen rekam medis, mencari dan mengantarkan dokumen rekam medis yang dipinjam.

		• Mengontrol pengembalian rekam medis yang dipinjam dengan mencocokkan rekam medis yang kembali pada SIM RS • Memasukan hasil penunjang medis susulan dari unit lain. • Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk menyelesaikan / menangani bila terjadi penyimpangan/kasus yang terjadi di kegiatan penjabaran dan pendistribusian rekam medis pasien rawat jalan/inap • Mencocokkan dokumen rekam medis yang kembali dan keluar dengan SIM RS
		5. Tanggung Jawab : • Bertanggung jawab atas dokumen rekam medis yang keluar dari rak penyimpanan. • Bertanggung jawab atas peminjaman rekam medis. • Bertanggung jawab atas dokumen rekam medis yang dipinjam. • Bertanggung jawab atas dokumen rekam medis yang diminta untuk semua kepentingan pengobatan pasien. • Bertanggung jawab atas kesesuaian dokumen rekam medis yang kembali dan keluar dengan buku ekspedisi. • Bertanggung jawab atas tersimpannya seluruh rekam medis diruang penyimpanan dengan rapi dan tepat sesuai nomor. • Bertanggung jawab atas tersedianya dokumen rekam medis kepada dokter yang akan mengisi formulir asuransi, perusahaan rekanan, visum et repertum dan lainnya.
		6. Wewenang • Koordinasi dengan petugas pendaftaran. • Koordinasi dengan petugas poliklinik. • Koordinasi dengan petugas IGD • Koordinasi dengan petugas IRNA. • Meminta arahan dari atasan. • Meminta masukan dari unit kerja lain yang terkait. • Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan
No	Nama jabatan	Persyaratan jabatan
6	Staf Laporan	1. Pendidikan : - Lulusan D3 Rekam Medis - Memiliki STR dan SIK yang masih berlaku 2. Pengetahuan dan Keterampilan : - Pelatihan tentang manajemen rekam medis - Menguasai ICD 10 - Menguasai ICD 9 CM - Menguasai pencatatan dan pelaporan dengan menggunakan program MS Excell 3. Pengalaman : Pengalaman kerja minimal 2 Tahun di bidang rekam medis
		4. Uraian Tugas : • Melaksanakan kegiatan statistik dan pelaporan yang meliputi:

		- Mencetak sensus harian rawat jalan dan rawat inap. - Mengontrol kebenaran sensus harian sesuai jumlah pasien yang sebenarnya. - Merekap sensus harian rawat jalan berdasarkan spesialisasi dan dokter prakteknya. - Merekap sensus harian rawat inap masuk dan keluar berdasarkan kelas, spesialisasi dan dokter yang merawat. - Meminta data kunjungan dari unit lain terkait dengan laporan kegiatan rumah sakit. - Membuat laporan kunjungan pasien rawat jalan, rawat inap dan penunjang. - Laporan morbiditas, mortalitas dan trend penyakit. - Membuat laporan ekstern ke Departemen Kesehatan dan jajarannya. • Menyediakan dokumen rekam medis untuk kepentingan pengisian form asuransi, perusahaan rekanan, visum et repertum atau pihak ketiga yang berhak. • Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. • Membuat laporan kegiatan pelaporan dan statistik untuk kepentingan laporan Unit rekam medis secara keseluruhan
		5. Tanggung jawab • Bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan penggunaan sensus harian. • Bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan laporan kunjungan pasien rawat jalan, inap dan penunjang, laporan morbiditas, mortalitas, dan penyakit menular, efisiensi pelayanan rawat inap, BOR, LOS. • Bertanggung jawab atas terisinya form asuransi, perusahaan rekanan, visum et repertum dan pengisian form untuk pihak ketiga yang berwenang. • Kebenaran laporan realisasi terhadap perencanaan / target yang ditetapkan.
		6. Wewenang • Mengatur rencana kegiatan statistik dan pelaporan • Meminta arahan dari atasan. • Mengeluarkan form asuransi, perusahaan rekanan, visum et repertum dan form dari pihak ketiga yang berwenang. • Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan

6.2. TUGAS KLINIS

Tugas klinis yang dimaksud adalah seseorang yang bekerja di bidang manajemen mempunyai uraian tugas jabatan dan uraian tugas fungsional dan dilengkapi oleh SPK dan RKK

NO	D3	D4	S1	S2
1	Melaksanakan kegiatan pelayanan pasien dalam manajemen dasar rekam medis dan informasi kesehatan		-	Mengembangkan desain rekam medis elektronik sesuai kebutuhan sistem pelayanan dan pelaporan dengan menggunakan biostatistik;
2	Melaksanakan evaluasi isi rekam medis	Merancang sistem evaluasi isi rekam medis manual dan elektronik;	-	Mengembangkan desain yang spesifik sesuai kebutuhan pengembangan modul penelitian bersama dengan kelompok profesi lain;
3	Melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodefikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai terminologi medis yang benar;	Mengevaluasi sistem klasifikasi klinis dan kodefikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis dalam pembiayaan Kesehatan	Mengevaluasi sistem klasifikasi klinis dan kodefikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis;	Mengembangkan kemampuan analisa <i>trend</i> penyakit dan mendistribusikan sesuai dengan otorisasi akses dan keamanan data;
4	Melaksanakan indeks dengan cara mengumpulkan data penyakit, kematian, tindakan dan dokter yang dikelompokkan pada indeks;	Memvalidasi indeks dengan cara menilai kumpulan data penyakit, kematian, tindakan dan dokter yang dikelompokkan pada indeks	Memvalidasi indeks dengan cara menilai kumpulan data penyakit, kematian, tindakan dan dokter yang dikelompokkan pada indeks	Mengembangkan kerja sama dengan tim epidemiologi dalam mendesain rancangan survei penyakit serta dalam demografi kependudukan;
5	Melaksanakan sistem pelaporan dalam bentuk informasi kegiatan pelayanan kesehatan;		-	Mengembangkan sistem informasi kesehatan masyarakat berbasis <i>website/</i> situs; dan

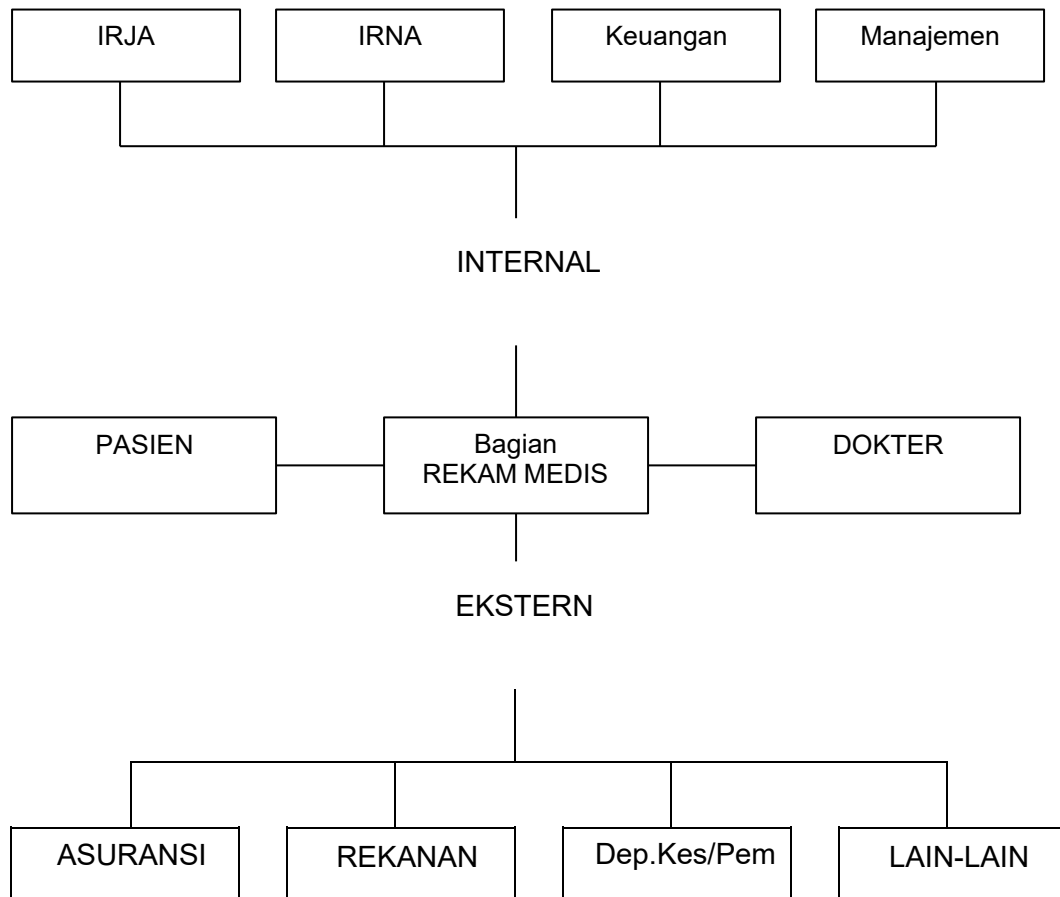
6	Merancang struktur isi dan standar data kesehatan, untuk pengelolaan informasi kesehatan;	Merancang struktur isi dan standar data kesehatan, untuk pengembangan informasi kesehatan	Merancang dan mengembangkan struktur isi dan standar data kesehatan, untuk pengembangan informasi kesehatan	Mengembangkan sistem evaluasi pelayanan rekam medis elektronik yang dipublikasikan.
7	Melaksanakan evaluasi kelengkapan isi diagnosis dan tindakan sebagai ketepatan pengkodean;	Memvalidasi kelengkapan diagnosis dan tindakan medis sebagai ketepatan pengkodean	Memvalidasi kelengkapan diagnosis dan tindakan medis sebagai ketepatan pengkodean	
8	Melaksanakan pengumpulan, validasi dan verifikasi data sesuai ilmu statistik rumah sakit;	Melaporkan hasil monitoring kinerja mutu pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi	Melakukan analisis data menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi	
9	Melakukan pencatatan dan pelaporan data surveilans;	Memvalidasi kumpulan dan verifikasi data sesuai dengan jenis formulir survey	Memvalidasi kumpulan dan verifikasi data sesuai dengan jenis formulir survey	
10	Mengelola kelompok kerja dan manajemen unit kerja dan menjalankan organisasi penyelenggara dan pemberi pelayanan kesehatan;	Menganalisa dan mengevaluasi pengelolaan manajemen unit kerja serta menjalankan organisasi fasilitas pelayanan Kesehatan	Menganalisa kegiatan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan;	
11	Mensosialisasikan setiap program pelayanan rekam medis		Memberikan kontribusi pada kegiatan riset bidang pelayanan rekam	

	dan informasi kesehatan;		medis dan informasi Kesehatan	
12	Melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan kode etik profesi; dan	Melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan kode etik profesi	Melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan kode etik profesi	
13	Melakukan pengembangan diri terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi		Melakukan pengawasan pengelolaan informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip sistem rekam medis dan informasi kesehatan/Manajemen Informasi Kesehatan	
14		Menyelesaikan masalah secara prosedural baik manual/elektronik; dan	Membuat identifikasi permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi	
15			Merancang dan mengembangkan sistem jaringan rekam medis manual dan elektronik;	
16			Membuat rancangan alternatif solusi pengelolaan informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip	
17			Menciptakan rancangan baru (inovasi) alternatif solusi pengelolaan informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip	
18			Melakukan komunikasi kemitraan peneliti di bidang manajemen	

		informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip sistem rekam medis dan informasi kesehatan/Manajemen Informasi Kesehatan	
--	--	---	--

BAB VII
TATA HUBUNGAN KERJA

7.1. SKEMA HUBUNGAN KERJA.



Hubungan tata kerja di Unit Rekam Medis bersifat garis komunikasi, koordinasi dan informasi dalam pelaksanaan kegiatan. Dilakukan melalui pertemuan dan atau surat dinas.

7.2. HUBUNGAN INTERNAL.

1. Unit rekam medis mengelola, memvalidasi, dan menyediakan hak akses data klinis elektronik (*user access control*) sebagai bahan komunikasi, koordinasi, dan informasi penunjang keputusan medis maupun manajerial untuk Instalasi Rawat Jalan (IRJA), Instalasi Rawat Inap (IRNA), Instalasi Gawat Darurat (IGD), Bagian Keuangan, dan Manajemen.. Misal: Dengan adanya SPO yang berkenaan dengan Dokumen Rekam Medis dalam pelayanan yang berkaitan dengan IRJA, IRNA maupun IGD
2. Unit rekam medis berfungsi sebagai mediator teknis dan verifikator antara pasien dengan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) untuk memastikan ketersediaan ringkasan medis elektronik.. Misal: SPO Permintaan pengisian Resume dokter bagi setiap pasien pengguna asuransi

7.3. HUBUNGAN EKSTERNAL.

1. Unit rekam medis merupakan penyedia informasi kepada pihak ketiga yaitu Asuransi, Rekanan dan pihak lain.
Misal: Memberikan pelayanan pendaftaran pasien asuransi seoptimal mungkin yang dituangkan ditegaskan kedalam sebuah SPO

2. Unit rekam medis wajib melakukan sinkronisasi data klinis langsung ke platform nasional SATUSEHAT milik Kementerian Kesehatan, serta melakukan pelaporan berkala melalui sistem SIRS Online (Sistem Informasi Rumah Sakit) terupdate.

BAB VIII
POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI

8.1. POLA KETENAGAAN

1. Penyusunan Pola Ketenagaan Sebagai Dasar Penempatan Staf

Upaya penyediaan dan pemeliharaan tenaga rekam medis yang kompeten dilakukan melalui tata kelola manajemen SDM yang adaptif terhadap transformasi digital kesehatan. Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan (SDMK) di Unit Rekam Medis dirancang sebagai proses sistematis untuk mengantisipasi serta mengelola perputaran tenaga kerja (rekrutmen, retensi, mutasi, dan pensiun) secara terukur. Tujuan Perencanaan SDM:

- a. Optimalisasi Pendayagunaan: Menjamin alokasi dan pemanfaatan seluruh staf rekam medis berjalan seefektif mungkin guna meminimalkan kejenuhan kerja (burnout).
- b. Kesesuaian Kualifikasi: Menyediakan jumlah tenaga profesional yang tepat waktu dan memenuhi standar kompetensi jabatan terbaru, khususnya keahlian tata kelola RME, keamanan data, koding klinis (ICD-10 & ICD-9-CM), dan analisis data kesehatan.
- c. Keberlanjutan Organisasi: Mempertahankan serta meningkatkan kapabilitas unit dalam mencapai sasaran strategis fasilitas pelayanan kesehatan melalui program pengembangan kontribusi yang berkelanjutan.

Strategi Pengembangan dan Retensi Staf Untuk mewujudkan unit kerja yang handal di era digital, perencanaan SDM wajib mencakup tiga pilar taktis berikut:

- a. Analisis Beban Kerja (ABK) Digital: Menghitung kebutuhan riil kuantitas staf secara periodik menggunakan indikator beban kerja modern (seperti volume transaksi RME, kecepatan validasi data, dan audit berkas klaim elektronik) agar beban kerja terdistribusi secara adil.
- b. Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan: Menyusun peta jalan pelatihan (training roadmap) terstruktur, meliputi sertifikasi koding klinis, pelatihan perlindungan data pribadi (PDP), serta manajemen risiko keamanan siber (cybersecurity awareness).
- c. Manajemen Rencana Suksesi: Memetakan jalur karier (career path) yang jelas serta sistem penghargaan (reward system) berbasis kinerja (KPI) untuk menekan angka perputaran karyawan (turnover) dan menjaga stabilitas operasional unit.

Tabel 1. Pola Kebutuhan Tenaga Rekam Medis Berdasarkan Analisa Beban Kerja

NO	TUGAS POKOK	URAIAN TUGAS	RERATA VOLUME KERJA PERHARI	WAKTU YG DIBUTUHKAN	
				SATUAN	JUMLAH
1	Assembling dan Analisa	Menerima dokumen rekam medis rawat inap	28	1	28
		Menyusun dokumen rekam medis sesuai urutan	28	7	196

		Menganalisa kelengkapan dokumen rekam medis rawat inap	28	7	196
		Menganalisa kelengkapan dokumen rekam medis rawat jalan	300	2	600
		Memisahkan dokumen rekam medis yang belum lengkap untuk di lengkapi	40	5	200
		Menyusun dan menyiapkan dokumen rekam medis baru rawat jalan dan rawat inap	150	7	1050
TOTAL					2270
JAM KERJA					420
JUMLAH TENAGA YANG DI BUTUHKAN					5.4= 5

NO	TUGAS POKOK	URAIAN TUGAS	RERATA VOLUME KERJA PERHARI	WAKTU YG DIBUTUHKAN	
				SATUAN	JUMLAH
2	Filling	Menerima permintaan dokumen rekam medis dari pendaftaran	350	0.1	35
		Mengambil dokumen rekam medis sesuai permintaan	350	2	700
		Mencatat dokumen rekam medis yang akan keluar	350	1	350
		Mendistribusikan dokumen rekam medis ke poli yang di tuju	50	2	100
		Menerima dokumen rekam medis	400	1	400

		kembali setelah di pinjam			
		Memasukan lembar rawat jalan gawat darurat	5	2	10
		Memasukkan dokumen rekam medis ke dalam rak	400	2	800
TOTAL					2395
JAM KERJA					420
JUMLAH TENAGA YANG DI BUTUHKAN					5.7 : 6

NO	TUGAS POKOK	URAIAN TUGAS	RERATA VOLUME KERJA PERHARI	WAKTU YG DIBUTUHKAN	
				SATUAN	JUMLAH
3	Pelaporan	Mengambil sensus harian rawat inap di setiap ruangan	13	1	26
		Menginput sensus harian rawat inap	13	5	65
		Menginput sensus harian rawat inap covid di laporan online	5	1	5
		Membuat laporan kunjungan rawat jalan	1	10	10
		Membuat laporan kunjungan rawat inap	1	10	10
		Merekap kelengkapan pengisian dokumen rekam medis	1	50	20
		merekap laporan KLB	1	5	5
		Membuat permintaan laporan internal dan eskternal	5	20	100
		Menyediakan dokumen rekam medis untuk kepentingan	1	5	5

		pengisian form asuransi,			
TOTAL					246
JAM KERJA					420
JUMLAH TENAGA YANG DI BUTUHKAN					0.6 : 1

No	TUGAS POKOK	URAIAN TUGAS	RERATA VOLUME KERJA PERHARI	WAKTU KERJA YANG DIBUTUHKAN	
				SATUAN	JUMLAH
4	Pendaftaran	Memanggil antrian pasien	350	0.5	175
		Menerima pendaftaran pasien rawat jalan	350	2	700
		Entry data identitas sosial ke SIM RS	350	1.5	525
		Menyiapkan kelengkapan pasien	300	5	1500
		Pengisian dokumen rekam medis	50	3	150
		Distribusi rekam medis ke poli	50	1	50
		Menerima dan Entry data identitas sosial ke SIM RS pendaftaran pasien rawat jalan IGD	40	3	120
		Menerima pendaftaran pasien rawat inap	38	3	114
		Kie pasien dan pemesanan kamar perawatan	38	10	380
		Distribusi rekam medis ke IGD/rawat inap/poli	38	3	114
		Penyelesaian pendaftaran pasien	30	20	600
TOTAL					4428
JAM KERJA					420

JUMLAH TENAGA YANG DI BUTUHKAN	10.6= 11
--------------------------------	----------

Berdasarkan perhitungan diatas kebutuhan tenaga kerja untuk rekam medis

- Asembling dan analisa : 5 orang
- Filling : 6 orang
- Pelaporan : 1 orang
- Pendaftaran : 11 orang,

Namun demikian karena adanya kebijakan kepala rumah sakit bahwa unit rekam medis membuka pelayanan pendaftaran 24 jam maka kebutuhan petugas rekam medis bagian pendaftaran berjumlah orang dengan pembagian kerja sebagai berikut :

- Pagi : 4 orang
- Siang : 5 orang
- Malam : 1 orang
- Libur : 1 orang

Kesimpulan : kebutuhan tenaga petugas rekam medis tahun 2020 di butuhkan 23 orang
 Apabila dikemudian hari terdapat penambahan beban kerja meliputi penambahan volume pasien, maka akan dilakukan evaluasi perhitungan pola ketenaagaan ulang

2. Penempatan dan Penempatan Kembali Staf

Perencanaan kebutuhan yang tepat dengan jumlah yang mencukupi adalah hal yang sangat penting bagi asuhan pasien termasuk keterlibatan rumah sakit dalam semua kegiatan pendidikan dan riset. Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi. Sebagai contoh, seorang perawat yang memiliki kompetensi hemodialisis tidak dirotasi ke rawat jalan lain.

Pimpinan unit layanan membuat rencana pola ketenagaan dengan menggunakan proses yang sudah diakui untuk menentukan jenjang kepegawaian. Perencanaan kepegawaian meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Penempatan kembali dari satu unit layanan ke lain unit layanan karena alasan kompetensi, kebutuhan pasien, atau kekurangan staf;
 - Staf yang mempunyai kompetensi tambahan seperti pelatihan Instrumen, pelatihan Kegawatdaruratan Perinatologi, Pelatihan ICU dasar, Pelatihan Anestesi tidak dapat dirotasi ke unit lain dikarenakan terdapat unit prioritas yang khusus membutuhkan kompetensi tambahan tersebut. Misalnya Staf yang memiliki pelatihan Instrumen, ditempatkan di Instalasi Kamar operasi, sebaliknya staf yang mempunyai kompetensi ICU dasar di tempatkan di *Instalasi Care Unit* (ICU)
 - Penempatan staf dapat dilakukan apabila dalam unit tersebut terdapat kebutuhan mendesak sedangkan staf yang dibutuhkan belum tersedia, maka staf tersebut di rotasi sementara untuk menjaga stabilitas pelayanan dengan tetap memperhatikan kualifikasi dan Rincian Kewenangan Klinis yang sesuai.
- Mempertimbangkan keinginan staf untuk ditempatkan kembali karena alasan nilai-nilai, kepercayaan, dan agama;

Mengkaji keinginan staf untuk ditempatkan pada unit yang sesuai berdasarkan hasil psikotest, menggali nilai kepribadian staf apakah lebih berpotensi pada unit pelayanan atau manajemen, atau bahkan marketing yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi, surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis yang telah disetujui Direktur RS Prima Husada dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap staf mempunyai tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas dan fungsinya. Dalam hal ini kompetensi dan kewenangan menjadi dasar dalam menentukan penempatan, uraian pekerjaan, dan kriteria untuk evaluasi kinerja staf.

Uraian tugas juga diperlukan untuk tenaga kesehatan profesional dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Staf yang bekerja terutama di bidang manajemen dan fungsional. Contoh, dokter spesialis bedah merangkap sebagai Kepala Instalasi Kamar Operasi dan sebagai dokter bedah harus mempunyai STR, SIP, SPK, RKK dan sebagai kepala instalasi kamar operasi mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
- b. seseorang dalam program pendidikan dan bekerja di bawah supervisi maka program pendidikan menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan sesuai dengan tingkat pendidikannya;
- c. bagi mereka yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan melakukan praktik mandiri harus dilakukan proses untuk identifikasi dan memberikan wewenang melaksanakan praktik dengan dasar latar belakang pendidikan, kompetensi, pelatihan, dan pengalaman. Persyaratan standar ini berlaku untuk semua jenis staf yang harus ada uraian tugasnya. (contoh, penugasan penuh waktu, paruh waktu, dipekerjakan, sukarela, sementara)

3. EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN STAF

- a. Pemutakhiran dan evaluasi staf dilakukan setiap satu tahun sekali dan dilaporkan tiap bulan di laporan bulanan
- b. Dihadiri oleh Direktur, Kepala Bidang, Kepala Unit, SDM
- c. Setiap ada staf yang melakukan pengunduran diri
- d. Setiap penambahan jenis pelayanan, jumlah pasien dan jumlah alat yang mempengaruhi perhitungan awal pola ketenagaan

4. JUMLAH STAF UNIT

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH SDM		KET
		BERDASARKAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA	KONDISI SAAT INI	
1	Kepala Unit rekam medis	1 orang	1 orang	sesuai
2	Filling	6 orang	6 orang	sesuai
3	Asembling dan analisa	5 orang	5 orang	sesuai
4	Pelaporan	1 orang	1 orang	sesuai
5	Pendaftaran	11 orang	11 orang	sesuai

d. KUALIFIKASI SDM UNIT REKAM MEDIS

No	Nama Jabatan	Kualifikasi		Kebutuhan
		Pendidikan	Sertifikat/Pelatihan	
	Ka Unit	Minimal D3 Rekam Medis	- Memiliki sertifikat dasar rekam medis - Pelatihan ICD 10 - Pelatihan ICD 9 CM - Pelatihan pelaporan rumah sakit - Pelatihan manajerial rumah sakit	1
	Filling	Minimal pendidikan SMA	Pelatihan tentang manajemen rekam medis	6
	Analisa dan assembling	Minimal D3 Rekam Medis	Pelatihan tentang manajemen rekam medis	5
	Pelaporan	Minimal D3 Rekam Medis	Pelatihan tentang manajemen rekam medis	1
	Coding	Minimal D3 Rekam Medis	- Pelatihan tentang manajemen rekam medis - Menguasai ICD 10 - Menguasai ICD 9 CM	-
	Pendaftaran	Minimal pendidikan SMA	Menguasai atau bisa program computer	11

BAB IX

PROGRAM ORIENTASI

Pengertian Orientasi adalah usaha membantu para pekerja agar mengenali secara baik dan mampu beradaptasi dengan suatu situasi atau dengan lingkungan / iklim bisnis suatu organisasi / perusahaan.

Orientasi harus mampu membantu para pekerja baru untuk memahami dan bersedia melaksanakan perilaku sosial yang mewarnai kehidupan organisasi / perusahaan sehari-hari.

Orientasi juga harus mampu membantu para pekerja baru untuk mengetahui dan memahami berbagai aspek teknis pekerjaan/ jabatannya, agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif, efisien dan produktif.

HARI	MATERI	METODE	PENANGGUNG JAWAB
UNIT REKAM MEDIS			
Hari I	Orientasi hari pertama : ➤ Penjelasan tentang pedoman pelayanan rekam medis ➤ Penjelasan tentang struktur organisasi rekam medis ➤ Penjelasan tentang SPO rekam medis ➤ Penjelasan tentang Pelaporan Pelaporan yang ada di bagian Rekam Medis ➤ Pembelajaran SIM RS	Penjelasan singkat Teori dan Praktek	Kepala Bagian Rekam Medis
Hari ke 2-3	Orientasi Hari Ke 2 Sampai Hari Ke 3 Meliputi ➤ Penjelasan tentang sistim Penyimpan ➤ Penjelasan Tentang Sistim Penjajaran ➤ Penjelasan Tentang Rekam Medis Aktif dan Inaktif. ➤ Penjelasan Tentang Penggunaan Out Guide,Tracer. ➤ Praktek Mengambil Dokumen Rekam Medis di Ruang Penyimpanan.		Kepala Bagian Rekam Medis / penanggung jawab filling

Hari ke 4-5	Orientasi Hari Ke 4 Sampai Hari Ke 5 Meliputi ➤ Penjelasan Tentang Sensus Harian IRNA ➤ Penjelasan Tentang Hari Perawatan dan Lama dirawat ➤ Penjelasan Tentang Bed Occupation Ratio ➤ Praktek Mengambil Sensus di Ruangan ➤ Praktek Pengurutan Sensus Per Jenis Pelayanan ➤ Praktek Menginput Data Sensus ke Komputer Dengan Menggunakan Program Mic Exel	Teori dan Praktek	Penanggung Jawab sensus harian
Hari ke 6-7	Orientasi Hari Ke-6 Sampai Hari Ke-7 Meliputi ➤ Pengenalan Tentang Buku Exspedisi Penyerahan Dokumen Rekam Medis Dari Rawat Inap. ➤ Penjelasan Tentang Pengurutan Dokumen Rekam Medis/Assembling ➤ Penjelasan Tentang Evaluasi Kelengkapan DRM ➤ Penjelasan Tentang Informed Consent ➤ Penjelasan Tentang Laporan Kelengkapan DRM.	Teori dan Praktek	Kepala Bagian Rekam Medis Petugas Assembling dan Evaluasi
PENDAFTARAN			
Hari ke 1-4	➤ Penjelasan Tentang Lembar Lembar Yang Digunakan Dalam Proses Admission. Sebelum Dokumen di distribusikan ke Poliklinik ➤ Praktek Admission Penjelasan dan Praktek Tentang Penggunaan computer dan SIM RS	Teori dan Praktek	Kepala Bagian Rekam Medik / Koordinator Pendaftaran
Hari ke 5	➤ Penjelasan Tentang Proses Pendaftaran Pasien Umum, BPJS dan Asuransi. ➤ Praktek Mendaftar Pasien Umum ➤ Praktek Mendaftar Pasien BPJS	Teori dan Praktek	Koordinator Pendaftaran

Hari ke 6-7	➤ Penjelasan Tentang Pendaftaran Pasien Rawat Inap dan Persyaratannya jika pasien BPJS ➤ Praktek Mendaftar Pasien Rawat Inap ➤ Praktek menginput data Pasien Rawat Inap Melalui Komputer	Praktek dan Teori	Kepala Bagian Rekam Medis Koordinator Pendaftaran
----------------	--	-------------------	---

BAB X
PERTEMUAN/RAPAT

10.1. RAPAT RUTIN BULANAN

Rapat Rutin koordinasi dibawah Ka Unit rekam medis diselenggarakan pada

Hari/tgl : Setiap awal bulan minggu pertama

Jam : 14:00 s/d selesai

Tempat : Ruang Unit Rekam Medis

Peserta : Seluruh anggota rekam medis

10.2. RAPAT KERJA ANTAR UNIT.

Rapat Kerja antar unit bersama Direksi diselenggarakan pada :

Waktu : Setiap Satu Bulan Sekali

Jam : 13:30 s/d selesai

Tempat : Ruang Andalusia

Peserta : Seluruh Kepala Unit /Instalasi, Kepala Bidang/Kepala Bagian dan Direktur.

10.3. RAPAT INSIDENTIL.

Rapat Insidentil diselenggarakan pada :

Waktu :Sewaktu-waktu bila ada masalah atau sesuatu hal yang perlu dibahas dan diselesaikan segera.

Jam : Sesuai undangan

Tempat : Sesuai undangan

Peserta : Seluruh petugas rekam medis.

Materi : Sesuai dengan masalah yang perlu dibahas

BAB XI

PELAPORAN

11.1. Laporan Harian :

- Input sensus harian
- Kirim data satu sehat
-

11.2. Laporan Bulanan :

- 10 Besar Penyakit Rawat Inap dan Rawat Jalan
- Rekapitulasi kunjungan rawat jalan dan rawat inap
- Rekapitulasi kunjungan percara bayar
- Laporan tingkat hunian
- Indeks dokter rawat jalan
- Indeks dokter rawat inap
- Jumlah kunjungan pasien tiap poli
- Laporan RL 3.1 Indikator Pelayanan
- Laporan RL 3.2 Rawat Inap
- Laporan RL 3.3 Rawat Darurat
- Laporan RL 3.4 Pengunjung
- Laporan RL 3.5 Kunjungan
- Laporan RL 3.6 Kebidanan
- Laporan RL 3.7 Neonatal, Bayi, dan Balita
- Laporan RL 3.8 Laboratorium
- Laporan RL 3.9 Radiologi
- Laporan RL 3.10 Rujukan
- Laporan RL 3.12 Pembedahan
- Laporan RL 3.14 Pelayanan Khusus
- Laporan RL 4.1 Morbiditas Pasien Rawat Inap
- Laporan RL 4.2 10 Besar Penyakit Rawat Inap
- Laporan RL 4.3 10 Besar Kematian Penyakit Rawat Inap
- Laporan RL 5.1 Morbiditas Pasien Rawat Jalan
- Laporan RL 5.2 10 Besar Kasus Baru Penyakit Rawat Jalan
- Laporan RL 5.3 10 Besar Kunjungan Penyakit Rawat Jalan
- Laporan STP
- Laporan Morbiditas
- Laporan Penderita TBC
- Laporan kelengkapan pengisian rekam medis

11.3. Laporan Tahunan

- Laporan RL 3.11 Gigi dan Mulut

- Laproan RL 3.13 Rehabilitasi Medik
- Laporan RL 3.15 Kesehatan Jiwa
- Laporan RL 3.16 Keluarga Bencana
- Laporan RL 3.17 Farmasi Rumah Sakit Pengadaan Obat
- Laporan RL 3.18 Farmasi Rumah Sakit Resep
- Laporan RL 3.19 Cara Bayar

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep